

✓ 高性价比人生指南

用最少的钱、时间和精力， 换回寿命、金钱和自由

长寿防病 · 急救 · 省钱理财 · 法律红线 · 失业兜底 · 恋爱婚育 · 出国 · 技能

667 条建议

A 级证据 435 条

1675 条原始文献链接

可按性价比筛选

讲怎么活得久、怎么少生病，出了意外怎么救。讲怎么少花冤枉钱，哪些事会让人被骗、摊上官司。讲没工作没钱时能去领什么，开店、开公司、做网站要办什么手续。也讲恋爱结婚生孩子、出国和学手艺。法律、医保、社保这些制度上的内容，按中国大陆的现行规定写。667 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引期刊论文和官方文件，少数官方不公开的案件引署名的原创新闻报道并附网页存档。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数，作者自己也没做到其中大部分。本项目从未发行、也不会发行任何代币或数字资产。用本项目名字发的币都和本项目无关，作者不领取、不认领任何相关收益。看到这类币请当作骗局，别买，见[第 5 节第 45 条（别买虚拟货币）] (book/05-不要浪费钱.md)。

生成于 2026-10-06 11:03（北京时间） · 正文提交 20718ee

正文每天都在改，以在线版为准：<https://eternity4719.github.io/HowToLiveBetter/>
在线检索、EPUB 与本 PDF 的最新版都在 <https://github.com/eternity4719/HowToLiveBetter>

目录

前言	1
各节简介	8
1. 不要早死	11
2. 不要慢慢死	34
3. 不要浪费精力	54
4. 不要浪费时间	65
5. 不要浪费钱	72
6. 反面清单	97
7. 没钱的时候怎么活	117
8. 别把自己搭进去：法律与财产安全	130
9. 普通人容易踩的法律红线	159
10. 恋爱和结婚划不划算	177
11. 程序员和技术人容易踩的红线	188
12. 创业与做生意：别把家底赔进去	199
13. 紧急情况：先做什么	214
14. 账号与信息安全	239
15. 租房与买房	244
16. 得了慢性病之后怎么活	248
17. 家里有老人	253
18. 养孩子划不划算	259
19. 在职、离职和工伤	261
20. 刚出生的孩子怎么带	271
21. 出国、旅行与境外安全	277
22. 怎么放松：娱乐场所和减压	282
23. 学什么技能划算	287
24. 看病：怎么少花钱少走弯路	299
25. 人走了以后要办什么	306
26. 做一个网站或平台：资质、备案和服务器	311
27. 怀孕和生产：从发现怀孕到出院办证	318
28. 别为了外形把身体搞坏	325
29. 遭遇重大打击之后	330
30. 上学以后的孩子	337
31. 十八岁之后有哪几条路	348
32. 出国留学：身份、打工、保险和回国认证	362
33. 残疾之后怎么活	366
34. 家里的常备药别吃出事	377
结婚划不划算：把一笔糊涂账拆成五笔清楚账	383
家庭应急装备清单：买什么、放哪里、多久检查一次	388
路上遇到陌生人出事，走开还是停下	391
做平台要办哪些证：对照表与选服务器的决策表	394
身体怎么认时间，夜班又为什么伤人	397
被裁了之后先做什么	401
孩子出生前后要办的事：按时间排的清单	403
刚确诊慢性病之后：头一周、头三个月和以后各做什么	405

换工作、换城市之前：要算的几本账和要办的手续 407

版本说明 411

前言

讲怎么活得久、怎么少生病，出了意外怎么救。讲怎么少花冤枉钱，哪些事会让人被骗、摊上官司。讲没工作没钱时能去领什么，开店、开公司、做网站要办什么手续。也讲恋爱结婚生孩子、出国和学手艺。法律、医保、社保这些制度上的内容，按中国大陆的现行规定写。667 条建议，每条写明花掉什么、换回什么、证据有多硬，来源只引期刊论文和官方文件，少数官方不公开的案件引署名的原创新闻报道并附网页存档。不用全做：这是按性价比排好的备选单，不是任务清单——挑走一两条就算数，作者自己也没做到其中大部分。**本项目从未发行、也不会发行任何代币或数字资产。**用本项目名字发的币都和本项目无关，作者不领取、不认领任何相关收益。看到这类币请当作骗局，别买，见[第 5 节 第 45 条（别买虚拟货币）](#)。

这本书想回答的问题

问题	去哪看
几乎不花钱，就能明显降低早死概率的事有哪些？	1. 不要早死
抽烟、喝酒、久坐、熬夜到底折寿多少，烟和酒具体怎么戒，家常食用油怎么选怎么用？	2. 不要慢慢死
每天精力不够用、总被打断，怎么改？	3. 不要浪费精力
时间都花哪去了，怎么少做无收益的事，拖延怎么治？	4. 不要浪费时间
攒下的钱该怎么放，才不被利息、费率和骗局吃掉？	5. 不要浪费钱
哪些保健品、体检套餐、智商税可以直接不买？	6. 反面清单
失业了、被欠薪了、身上没钱了，能领什么、去哪求助？	7. 没钱的时候怎么活
彩礼、婚前房产、恋爱期间的大额转账算谁的，被人报案指控或捏造事实举报时第一步做什么，自己惹了事主动去说能减多少刑，事后能不能追究和索赔？	8. 法律与财产安全
哪些「兼职」和顺手的小事会让普通人变成刑事被告？	9. 普通人容易踩的法律红线
追人该广撒网还是死磕一个，异地恋能不能成，领证要带什么？	10. 恋爱和结婚划不划算
写哪些代码、接哪些单会被判刑？	11. 程序员和技术人容易踩的红线
借钱开店、开公司之前最该先想清楚什么？	12. 创业与做生意
有人倒地没了呼吸、大出血、火灾、迷路，先做什么？	13. 紧急情况：先做什么
账号被盗、手机丢了，第一步做什么？	14. 账号与信息安全
押金被扣、房东赶人、长租公寓暴雷怎么办，想搬去乡下住能不能买农村的房？	15. 租房与买房
确诊慢性病之后，长期该怎么管、怎么少花钱？	16. 得了慢性病之后怎么活
老人的监护、遗嘱和钱该怎么提前安排？	17. 家里有老人
生孩子能领什么、要占掉多少时间和钱？	18. 养孩子划不划算

问题	去哪看
加班费、年休假该怎么算，被裁该拿多少补偿，上班受了伤怎么认定和拿钱？	19. 在职、离职和工伤
孩子刚出生，最要紧的几件事是什么？	20. 刚出生的孩子怎么带
哪些国家现在别去，出事了使领馆管到哪一步？	21. 出国、旅行与境外安全
去 KTV、网吧、密室怎么不踩坑，压力大时做什么最有用？	22. 怎么放松：娱乐场所和减压
学电焊、学英语、考证，哪些真的回本，怎么学才省时间，职称从哪里报、值不值？	23. 学什么技能划算
同一个病在社区看和在三级医院看差多少钱，伤得很重时是挂号排队还是找急诊分诊台，治完要不要做伤残鉴定、办残疾人证，种一颗牙该花多少钱、医保报不报？	24. 看病：怎么少花钱少走弯路
家里人走了，当时先做什么、哪些钱能取回来、哪些费用可以不交？	25. 人走了以后要办什么
做个网站或平台收钱，要办哪些证、服务器放哪？	26. 做一个网站或平台
怀孕了、要生了，什么时候做什么，出院前要办哪些证？	27. 怀孕和生产
想减肥、想变好看、想矫正牙齿，哪些做法会把身体搞坏？	28. 别为了外形把身体搞坏
亲人走了、被裁了、拿到重病诊断，头几个月最要紧的是什么？	29. 遭遇重大打击之后
孩子上学以后，哪些身体和心理的事不能等到考完再说？	30. 上学以后的孩子
十八岁之后除了读书和打工还有哪几条路，各自的门槛是什么？	31. 十八岁之后有哪几条路
出国留学，签证身份怎么才算没断，回国这张文凭认不认？	32. 出国留学：身份、打工、保险和回国认证
自己或者家人残疾了，先防住哪些并发症，能申请哪些补贴，上学就业和监护怎么办？	33. 残疾之后怎么活
感冒药、退烧药、胃药自己买来吃，哪些不能一起吃，孩子、孕妇和老人要避开哪些？	34. 家里的常备药别吃出事

怎么读

- **不用全做：**这是一份按性价比排好的备选单，不是任务清单。挑走一两条就算数，剩下的放着，需要时再回来查。「说着容易做着难」这个评价是对的——作者自己也没做到其中大部分，写下来是为了要用的时候找得到。想挑省力的，看下面「只想看最值得做的」那条。
- **想让 AI 帮你查：**仓库里带了一个中文 skill ([skills/life-decision-guide](#))，Claude Code 和 Codex 都能装。装上以后直接问「替朋友担保签不签」「每天通勤两小时值不值」。它会先把相关条目从正文里查出来，再照书里的算账方式排序回答，并注明出自第几节第几条。查不到就说查不到，不自己编数字。装法见 [那个目录的说明](#)。

- **想按条件挑**：打开[在线检索页](#)，可以按关键词、章节、证据等级来筛，也可以按「花不花钱、花多少时间、要不要毅力」这三样筛，几个条件能叠着用。页面上的内容直接取自 book/ 目录里的正文，正文一改，页面跟着改。
- **条目之间会互相指路**（「见第 8 节第 17 条」这种）：在检索页里，这种指路带一条虚线。点一下，就地显示被指的那条的标题和「说人话」。想真的翻过去，再按「跳过去」。那一条正好被筛选条件藏起来了，页面会自动把筛选清掉。在 GitHub 上直接读正文点不动，但每处指路后面都写着指向什么（「见第 18 条（借钱写清借条）」）。不翻过去也知道说的是哪条。
- **想按顺序读**：每节内的条目按性价比从高分到低分排列，从每节前几条开始看就行。
- **想离线看、想发给别人**：下载 [离线单文件 HTML](#)，整本书连同检索和筛选都在这一个文件里，双击就开，不用服务器也不用联网，微信里也能直接传。
- **想打印或在手机上翻**：下载 [PDF](#)，A4 排版、两百多页，带目录页码和书签，每节另起一页。
- **想在 Kindle 或其他阅读器上读**：下载 [EPUB 电子书](#)，Kindle 用 Send to Kindle 发过去即可。
- **三样都是正文每次更新后自动重新生成的**，下载链接固定不变；转发出去的那一份不会跟着更新，以在线版为准。
- **看不懂那串数字**：每条都有一行「说人话」。它把「收益」栏里那些研究里的写法，翻成「同期死亡的概率低约两成」「拘留几日、罚多少钱」这样的日常说法。它只用「收益」栏已经写到的内容，不添新数字。只看这一行就够拿主意。「收益」栏里原样留着全部数字，想自己核对就看那一栏。
- **只想看结论最硬的**：在检索页里勾选证据等级 A，只留下有具体数字、来自荟萃分析或大型试验的 435 条。
- **只想看最值得做的**：勾选性价比「极高」，得到 114 条既不花钱、不花时间、不需要毅力，收益又落在最大一档的条目。再叠加一个「换回什么」，就是该口径下的优先清单。
- **看到「不要」开头的节标题不用紧张**：节标题说的是这一节想防住的事（不要早死、不要浪费时间），不是说底下每条都在让你别干什么。真正要做的动作写在条目标题里，一律动词开头，自己就写清了是「做什么」还是「别做什么」。同一节里两种都有：第 4 节既有「把『打算做』写成『几点、在哪、遇到什么就做什么』」，也有「不看电视和滚动新闻」。按条目标题读，不用往节标题的语气上套。

每条建议长这样：

5. 把家里的食盐换成低钠盐（钾盐）

- 成本：一袋比普通盐贵几元。买的时候顺手换，不额外占时间。口味几乎不变。
- 说人话：得过中风或 60 岁以上有高血压的人，把家里的盐换成低钠盐，五年内死亡的概率低约 12%，中风低约 14%。
- 收益：一项把人随机分成两组的试验，在中国农村做的，20995 人，都是得过卒中的人或者 60 岁以上的高血压病人，跟踪了 4.74 年。结果：用低钠盐的那组比用普通盐的那组，死亡风险低约 12% (RR 0.88)。卒中低约 14% (RR 0.86)。主要心血管事件低约 13% (RR 0.87)。
- 证据等级：A
- 来源：Neal B 等 (2021). Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. NEJM. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2105675>
- 备注：争议。试验对象是高危老人，健康年轻人换盐得到的好处要小得多。肾功能不全的人，或者正在吃保钾类药物的人，换盐前先问医生。

自己跑一份

多数人用不着部署：[在线检索页](#)是现成的，要离线就下[离线单文件 HTML](#)，双击就开。

真要在自己电脑或服务器上跑：

```
git clone https://github.com/eternity4719/HowToLiveBetter.git
cd HowToLiveBetter
python -m http.server 8000
```

然后浏览器开 <http://localhost:8000/>。检索页是纯静态的，README.md 和 book/ 就是它的数据，没有后端、没有数据库、不用装依赖；把整个目录丢给任何静态服务器（Nginx、GitHub Pages、对象存储）效果一样。注意 index.html 必须经 http 打开，直接双击本地文件会空白——浏览器不许网页读本地文件，那种场景请用上面的离线单文件版。

想自己生成三样电子版（平时用不着，Release 里的就是自动生成的）：

```
cd tools/epub && npm ci && npm run build    # EPUB
node tools/offline/build.mjs                 # 离线单文件 HTML
node tools/pdf/build.mjs                      # PDF，另需 pandoc ≥ 3.1 和 typst ≥ 0.13
```

产物都在 dist/。

四种资源

这本书想帮你多留住的不只是寿命，一共四样东西：

- **寿命**：活得更久，少死于本来可以避免的事
- **时间与精力**：活着的时间不花在没有回报的事上，每天的注意力和体力少被白白耗掉
- **金钱**：少花冤枉钱，把钱花在收益确定的地方
- **人身自由**：不因为不知道一条红线，把自己送进拘留所或者看守所

每一条建议都回答两个问题：要花掉什么（钱/时间/精力/毅力），能换回什么（总死亡率变化 / 特定死因下降 / 时间与精力节省 / 金钱节省 / 保障与人身自由）。条目按性价比排，不按类别排：几乎不花什么成本、换回的好处又大的，放在最前面。

一条建议的好处落在谁身上，是分档的。按「这份好处将来有多大可能回到你自己身上」从高到低：

① **你自己**；② **配偶和直系亲属**（父母、子女、祖父母外祖父母、孙子女外孙子女）；③ **朋友、同事和其他亲属**——互惠关系，帮出去的将来可能回来；④ **陌生人**——最低一档，但不是零：回报的概率小，而且你不了解对方性格，还有被讹、被反咬、被报复的一面。不同档不合并计算，写到第 ④ 档时好处和风险一起写。

急救那一节照这个读：中国 38,227 例院外心脏骤停里 79.2% 发生在家里，学按压首先是为了按在自家人身上；「看到有人溺水自己不下水」「撞见斗殴别上手拉架」这类规则本身就是自保规则，防的是你从旁观者变成第二个伤者。对陌生人要不要出手是你自己的权衡，条目会把免责条款、自保动作和风险面都写清楚，不替你把它算成非做不可的理由。

死亡率的数字、时间精力的数字、金钱的数字和法律后果，各算各的，不互相折算。这四样对应检索页上那四个「换回什么」，彼此之间不比大小。

证据分级

每条建议都标注证据等级：

等级	含义
A	有具体数字可查，出处是多项研究合并起来的荟萃分析、跟踪很多人很多年的大型队列，或者随机分组的试验（RCT），能说出降了多少（HR、RR、下降百分比）
B	有研究支持，但说不出一个确切数字；或者只有小样本、单独一项研究撑着
C	作者自己的经验，或者大家公认的做法，没有直接的研究文献

全书 667 条中 A 级 435 条、B 级 177 条、C 级 55 条，另有 68 条标注了争议、3 处标注了 TODO 待核实。有争议的 A/B 级条目会标注「争议」并列出发方证据。所有来源只引原始文献（期刊论文附 DOI 或 PubMed 链接，或 WHO/CDC/国家统计局等官方机构报告），不引二手转述。官方不公开的案件，少数条目引了有记者署名的原创新闻报道，只用来说明「发生过这类事」，来源栏附网页存档，备注写明「只有媒体报道」。不确定的数字标「待核实」。

A 级只说明「有具体数字、出处可核」，不说明这个数字一定是因果。A 级里既有随机分组的试验，也有只跟踪记录、不分组的研究，后者分不清是这件事起了作用，还是做这件事的人本来就更健康。哪一种看收益栏：写着「随机分成两组」的是前者，写着「只记录、不分组」的是后者。法律和政策类条目的 A 级，指的是引到了法条或官方文件原文。

收益栏和说人话里的百分比，多数是比没做的人低几成，不是每一百人里少几个。同样低 12%，本来风险就高的老人少掉的死亡人数，远多于本来风险就很低的年轻人。所以先看说人话里写的是哪些人，再看那个百分比。

性价比档

证据等级只回答「这个数字可不可信」，不回答「这件事值不值得做」。所以每条还另外标了两样：收益量级（好处有多大）和口径（换回的是哪一类东西）。检索页拿这两样加上三项成本，合出一个性价比档：

维度	取值	怎么定的
口径	换寿命 / 换钱 / 换时间精力 / 换人身自由	看这条主要换回的是什么。 不同口径之间不做比较 ，「总死亡率降 12%」和「每年省 500 元」不在一把尺子上，没法分高下
收益量级	大 / 中 / 小	尽量照着条目自己的「收益」栏，按事先定好的界线套，不凭感觉：换寿命看降了百分之几（≥20% 为大，10-20% 为中，<10%、或者只量到中间指标而没量到最终结果的为小）；换钱看金额（万元级为大，数百到数千为中，几十元为小）；换人身自由看后果（避免刑事责任为大，避免拘留或行政处罚为中，避免民事纠纷为小）；换时间精力看省下多少（每天省出小时级为大，每周小时级为中，只省一次的为小）
性价比	极高 / 高 / 一般	好处大、三项成本又全是零 = 极高；好处大、成本不高，或者好处中等、成本为零 = 高；剩下的 = 一般

全书 667 条中性价比极高 114 条（17%）、高 303 条（45%）、一般 250 条（38%）。中间那档条数多是有意为的：底下的收益量级本来就只分大、中、小三级，再往细里切就是装出来的精确。

这一档是作者自己的判断，不是证据，按本书的标准它本身只算 C 级；它和证据等级是两回事，谁也不影响谁。一条可以证据是 A 级、性价比却只算一般（带状疱疹疫苗有 97.2% 效力的三期 RCT，但两针三四千元、带状疱疹很少致命），也可以证据只有 C 级、性价比却极高（出境前把行程发给家人）。「一般」不等于不该做——全书的条目都是建议做的，只是这一档得你自己掂量那笔花销值不值。

读懂数字（术语表）

正文尽量用日常说法，但引用研究的时候免不了出现几个统计名词。看不懂就查这张表；在线检索页里，把鼠标停在带虚线的词上（手机上点一下）也会弹出解释。

术语	意思
总死亡率	一段时间里，一群人当中死掉的人占多大比例，不管死于什么原因。本书用它衡量「活得久不久」。研究原文里叫全因死亡率，英文缩写 ACM

术语	意思
HR	风险比。同样一段时间里，做了某件事的那组人出事（死亡、得病）的快慢，除以没做的那组。HR 0.87 就是比没做的那组低 13%，HR 1.21 就是高 21%
RR	相对风险。两组人出事的可能性之比，数字怎么读和 HR 一样
OR	比值比。也是两组的对比，只是算法和 RR 略有不同：要比的那件事很少见时，它和 RR 差不多；那件事很常见时，它会把差距说得比实际大
IRR	发病率之比。发病率是一段时间里新得这个病的人占多大比例，两组相除，读法同 RR
RaR	发生次数之比。比的是事情发生了多少次（比如摔了多少跤），不是多少人出事，读法同 RR
标准化死亡比	英文缩写 SMR。这群人实际死了多少人，除以「同样年龄的普通人本该死多少人」。5.86 就是死的人数是同龄人的 5.86 倍
风险差	两组出事的概率相减，直接得出「每一千人里多出几个」。倍数只说翻了几倍，风险差说的是实实在在多了多少人
95% CI	95% 置信区间。研究算出的数字总有误差，这是真实情况很可能落在的范围。倍数类的数字，范围跨过了 1；加减类的数字，范围跨过了 0，就说明两组的差别可能只是碰巧，文中会写「无统计学意义」
RCT	随机对照试验。用抽签一样的办法把人分成两组，一组做这件事，一组不做，过后比结果差多少。要证明「是这件事起了作用」，这种做法最有说服力
荟萃分析	把很多项研究的结果凑到一起重新算，得出一个总的数字。也叫 meta 分析
队列	队列研究。挑一大群人跟踪很多年，记录谁出了事。能看出两件事常一起出现，但不足以证明是前一件造成了后一件
观察性	观察性研究。研究者只在旁边记录，不安排谁做、谁不做。结果容易被别因素带偏（见本表的混杂、反向因果两条），数字要打点折看
混杂	有第三个因素同时牵动着前因和后果，让两件事看起来像有因果。比如爱吃菜的人往往也更爱运动，分不清是哪一样在起作用
反向因果	因果的方向弄反了：看着像前一件引起后一件，其实是后一件引起前一件。不是睡得多让人早死，而是病重的人睡得多
d、g	效应量，表示两组的差距有多大。把差距换算成「相当于几倍的常见波动幅度」：0.2 算小，0.5 中等，0.8 大
r	相关系数。两件事跟着一起变的紧密程度，取值从 -1 到 1，0.1 算弱、0.3 中等、0.5 算强
MET	运动强度的单位。安静坐着是 1 MET，快走约 3 到 4 MET。写成 MET·h，就是强度乘以做了几小时，表示一共动了多少
GRADE	国际上通用的一套打分办法，给一项证据有多可靠评级，分高、中、低、极低四档
意向筛查分析	算效果时按「通知了谁去做筛查」算，不按「谁真的去做了」算。被通知的人里总有没去的，所以这种算法会把筛查对真去做的人的好处算低
包年	统计一个人一共抽了多少烟的单位。每天抽几包乘以抽了几年，30 包年就是每天一包抽了 30 年

术语	意思
BMI	体重指数，看胖瘦常用的一个数：体重的公斤数，除以身高米数的平方
LDL	低密度脂蛋白胆固醇，俗称坏胆固醇
eGFR	估算肾小球滤过率，衡量肾脏过滤能力的一项指标，单位 mL/min/1.73 m ² 。数越低说明肾功能越差，慢性肾病分几期就按它定
HBsAg	乙肝表面抗原，化验单上的一项。结果是阳性，表示已经感染了乙肝病毒
HPV	人乳头瘤病毒。它分很多型，其中一部分型长期感染会导致宫颈癌
LDCT	低剂量胸部 CT，辐射量约为普通 CT 的五分之一到十分之一
PM2.5	飘在空气里的细颗粒物，直径在 2.5 微米以下
NOVA	一种给食品分类的办法，按加工得有多厉害分成四类，「超加工食品」就是其中的第四类
LPR	贷款市场报价利率。国内贷款利率的基准，每月 20 日公布一次，房贷利率和民间借贷的利息上限都照着它算
一裁终局	劳动仲裁的结果下来就直接生效，单位不能再拿这件事去法院起诉
粗结婚率、粗离婚率	每一千人里，当年登记结婚、登记离婚的对数。另外还有个数叫离结比，是当年离婚对数除以结婚对数，和这两个不是一回事，别混着看
AED	自动体外除颤器。公共场所常见的红色或黄色急救箱，开机以后跟着语音提示做就行，要不要电击由它自己判断
CPR	心肺复苏。心脏骤停时用力按压胸口，让血继续流动
3C 认证	中国强制性产品认证。列进目录的那些产品，没印这个标志就不准出厂、不准卖
ICP 备案	网站或 App 正式上线之前，到工信部的系统里登记一道手续
等级保护	网络安全等级保护制度。按一套系统有多重要分成几个级别，级别越高，要做的安全措施越多
GPL	一种开源许可证。用了这类代码做出来的东西，往外发的时候通常也得把自己的代码一起公开
竞业限制	和公司签的一种约定：离职后一段时间内不去同行的对手那里上班。这段时间公司要按月给你补偿，最长 2 年
认缴出资	注册公司时承诺要投进去的钱。承诺了就得在法律定的期限内真掏出来，不是写个数字好看
定金与订金	两个词只差一个字，效力差很多：定金有罚则，收钱的一方反悔要双倍退还，金额最多为合同额的 20%；订金只是提前付的钱，反悔没有这个罚则

各节简介

1. **不要早死**：外因死亡、燃气与中毒、疫苗、筛查、心理危机与自杀念头的时​​间尺度、被救回来之后留下什么、坠落重伤之后的那一年、卖掉一个肾之后剩下那个肾的账、家庭应急装备、肉眼血尿等该去查的信号、65 岁以上女性查骨密度与查出骨质疏松就用药、上野外冰面前先量冰厚、用角磨机装好护罩戴护目镜。口径：总死亡率 或特定死因。
2. **不要慢慢死**：烟酒、运动、睡眠、饮食（低钠盐、坚果、全谷物、加工肉、散装自榨花生油、植物油代替猪油）、久坐，以及戒烟戒酒的具体办法（戒烟药、戒烟日、戒烟门诊与热线、电子烟、酒精戒断不能自己硬扛）、午睡时长、熬夜之后怎么补、上夜班的年数账、做饭开抽油烟机。口径：总死亡率 或特定死因。长文见 [docs/生物钟和夜班.md](#)。
3. **不要浪费精力**：睡眠、打断、多任务、人际负债、和机构打交道时该有的预期。口径：精力/时间。
4. **不要浪费时间**：无收益项目、沉没成本、拖延（情绪解释、改环境、承诺装置、习惯要多久、自助材料）、会议、通勤。口径：时间。
5. **不要浪费钱**：订阅、彩票、利息与借钱先换成年化利率、保险、基金费率、个人养老金、车险、预付款、直播带货、医保个人账户、孩子被骗与充值退款、手串名表潮玩不按投资算、珠宝玉石的检测报告怎么核、盲盒抽卡、想买海外资产走哪条合法渠道，节末六条讲保险：只给扛不住的损失买、挣钱的人先买定期寿险、犹豫期退保、银行柜台别把保险当存款、别找代理退保、受益人和理赔时效；最后一条是别买虚拟货币，买币的交易不受法律保护，亏了要不回来。口径：金钱。
6. **反面清单**：看起来性价比高但其实不高的东西，含「意志力会用完」这个说法，靠学搬运姿势防腰痛，以及骨折之后猛补钙、喝骨头汤。
7. **没钱的时候怎么活**：救助、补贴、找活、住宿吃饭、医疗、欠薪维权、避坑。口径：金钱/保障。
8. **别把自己搭进去：法律与财产安全**：交通事故、被骗止付、AI 换脸拟声、自首和如实供述能减少多少刑与「躲过追诉期」这条路为什么不通、被指控和被人捏造事实举报之后能走哪些路、拿举报要挟对方掏钱和自己正常索赔的分界、冲突与泄愤式极端暴力、伤人冲动与身边人的送诊权、给家人投保后动手的四道法律门、被网暴之后走平台与禁令、彩礼、婚前财产、担保、反诈、熟人让你刷脸、念验证码办贷款的 AB 贷、诉讼时效、被执行与失信名单、养犬责任、报警之后的受案回执与不立案救济、送钱摆平就是行贿罪、防入室盗窃的门窗锁与感应灯。口径：金钱/人身自由。
9. **普通人容易踩的法律红线**：谣言、侮辱英烈、境外内容只看不转、传播色情、兼职洗钱、伪造材料骗贷、伪造事故骗理赔、高空抛物、仿真枪、无人机、偷拍、养不了孩子时的合法送养与拐卖遗弃的界线、赌博、野味、卖器官与帮人找供体，第 24、25 条是著作权：汉化、搬运、分享网盘资源不收钱也侵权、挂广告收会员费就可能判刑，写同人拿去出版卖钱先拿许可，节末是为了防身带甩棍、电击器、匕首出门会被罚。口径：人身自由/金钱。
10. **恋爱和结婚划不划算**：择偶策略、纠缠的红线、兴趣信号、关系质量、异地恋、登记流程、婚检、健康账、时间账、钱账、父母出资买房与夫妻共同债务、退出成本、关系卡住了一起去做伴侣治疗。长文见 [docs/结婚划不划算.md](#)。
11. **程序员和技术人容易踩的红线**：外挂、爬虫、抢票脚本、删库、带走源码、接单开发、竞业、开源许可、备案、跳过或屏蔽别家广告的工具、AI 中转站。口径：人身自由/金钱。
12. **创业与做生意：别把家底赔进去**：本钱、担保、主体选择、注册登记、许可证、纳税申报、发票、涉税诈骗、合同、用人、量产、进货与用图的知识产权红线、退场，节末一条讲代运营、开店培训和「无货源」这类先收小钱再层层加钱的创业骗局。口径：金钱/法律责任。
13. **紧急情况：先做什么**：心脏骤停、卒中与后循环卒中、眼中风、心梗、主动脉夹层、霹雳样头痛、慢性硬膜下血肿、肺栓塞、大出血、咬伤、烧烫伤、过敏性休克、癫痫、低血糖、触电、一氧化碳、误服与化学品灼伤、扎进身体的异物、骨折固定、骗局、隐私威胁、中暑、火灾、溺水、迷路、失温、蛇咬、地震、野兽、雷击、高原病、蜱虫、野外饮水；还有救不救得起：老人摔倒怎么扶、撞见斗殴怎么办、救人受伤之后的钱找谁；节末是 1 岁以下婴儿噎住和婴儿心肺复苏。口径：存活率与金钱，末几条兼及人身自由。

14. **账号与信息安全**：二次验证、密码、SIM 卡、手机丢失、银行卡盗刷、登录设备、App 权限、人脸识别、查阅与删除权、来路不明的 AI 中转站。口径：金钱/个人信息。
15. **租房与买房**：押金、暴力腾退、中介代收、资金监管、买卖不破租赁、产权核对、交易资金专户、隔断房、城镇户口别买宅基地只能租农房。口径：金钱。
16. **得了慢性病之后怎么活**：服药依从、门诊慢特病跨省结算、复查记录、别停药试偏方、长期处方、家庭医生签约、并发症筛查、肾结石复发预防、痛风的达标治疗。口径：总死亡率/金钱。长文见 [docs/刚确诊慢性病之后.md](#)。
17. **家里有老人**：意定监护、遗嘱形式、账户与话术、投资养老与以房养老骗局、长期护理保险、长期卧床的压疮防护、白内障影响看路就去评估手术。口径：金钱/人身自由，压疮和白内障两条为死亡率。
18. **养孩子划不划算**：育儿补贴、产假与生育津贴、三期保护、时间账、钱账。口径：金钱/时间。
19. **在职、离职和工伤**：加班费、年休假、试用期；职业病危害告知与三次体检、粉尘噪声防护；N、代通知金、2N、别签主动辞职、留证；工伤认定时限、单位未参保、劳动能力鉴定、工亡待遇；离职证明、补偿的个税；换城市工作时养老和医保关系的转移。口径：金钱。长文见 [docs/被裁了之后先做什么.md](#) 和 [docs/换工作、换城市之前.md](#)。
20. **刚出生的孩子怎么带**：安全睡眠、乙肝首针、免疫规划疫苗、母乳与辅食、冲奶水温、蜂蜜、维生素 K、发热就医红线、不摇晃、尿布与大件采购、高危孩子早引入花生防过敏、新生儿黄疸的就医信号。口径：婴儿死亡率/金钱。
21. **出国、旅行与境外安全**：安全提醒级别、12308、领事保护的边界、境外医疗保险、境外高薪招聘骗局、境外取现的年度额度、证件丢失、境外驾照、中介备案。口径：金钱/人身自由。
22. **怎么放松：娱乐场所和减压**：安全出口、明码标价、涉毒红线、别人递的东西、剧本杀选址；运动、正念、呼吸、社交、绿地。口径：金钱/人身自由，以及精力/总死亡率。
23. **学什么技能划算**：读书还是打工（童工年龄线、教育与死亡率、全国学历结构、免学费与助学金助学贷款、中职升学通道、怎么自己算这笔账）、教育回报率、山寨证书、培训补贴、哪些本事不容易被机器取代、技能等级、紧缺职业怎么查，以及定下来学什么之后怎么学（自测、分散练习、别靠划重点、交错练习、学习风格没有证据），最后是职称（申报渠道、以考代评、代评造假的后果、评上不等于聘上）。口径：金钱/时间，其中一条为死亡率。
24. **看病：怎么少花钱少走弯路**：分级诊疗与转诊、起付线连续计算、报销比例差、预留号源、异地就医必要性评估、病历留存与封存、急诊预检分诊的四级顺序、无力支付时的疾病应急救助、伤残鉴定的时机、残疾人证怎么办、不用给医生送红包、种植牙的包干价与医保范围。口径：金钱/时间。
25. **人走了以后要办什么**：报警与死亡证明、遗体接运与火化、死因异议与尸检、注销户口、殡葬基础项目清单、价格违法、中介备案、公积金余额与社保待遇、死者个人信息权利。口径：金钱。
26. **做一个网站或平台：资质、备案和服务器**：支付结算红线、ICP 许可与备案、直播与视听资质、平台核验与涉税报送、内容治理、实名、未成年人、通知删除、数据出境、服务器选型。口径：人身自由/金钱。长文见 [docs/做平台要办哪些证.md](#)。
27. **怀孕和生产：从发现怀孕到出院办证**：叶酸、建册与免费产检、三病筛查与母婴阻断、孕期烟酒、阿司匹林与妊娠期糖尿病、立刻去医院的信号、破水处置、无痛分娩、剖宫产指征、生育保险、出生医学证明、新生儿筛查、参保与落户、产后 42 天复查。口径：死亡率与金钱。长文见 [docs/孩子出生前后要办的事.md](#)。
28. **别为了外形把身体搞坏**：极端节食与进食障碍、医美机构与主诊医师两证、面部填充的失明部位、违法添加西布曲明的减肥产品、合成代谢类固醇、减肥药与性激素的处方和复查、体像评估、正畸牙套要有医生当面检查和复诊。口径：死亡率（健康终点），医美两条兼及人身自由。
29. **遭遇重大打击之后**：丧亲头一个月的心血管窗口、重病诊断的第一周、失业、丧偶后的半年、因自杀丧亲、没有亲人也没有朋友时怎么替代那个人、家长去世的孩子、哀伤卡住了去哪挂号、离婚、12356 与 12355、别在应激期做不可逆的决定、用死还债这条路不通。口径：总死亡率，谈花钱与待遇的四条为金钱。

30. **上学以后的孩子**：按小时算的急症、别为了考试推迟治疗、被欺凌怎么办、每天户外 2 小时、学生体检报告单、青少年抑郁筛查、治愈近视的产品、睡眠与作业的硬规定、休学保留学籍、散瞳验光与复查、窝沟封闭、管孩子不打不吼骂、家长课、别送戒网瘾学校。口径：死亡率与健康终点，另有金钱和时间各一到两条。
31. **十八岁之后有哪几条路**：十二条路的法定门槛；当兵（兵役登记、义务兵两年、拒服兵役的联合惩戒、学费补偿与升学、安置与 30 日报到、退役金与工龄税收）；基层服务项目的定向考录；特岗教师期满入编；消防员与军队文职；自考、成人高考与开放大学；公费师范生与定向医学生的 6 年履约；出国打工找什么样的公司；在家给境外公司远程干活的个税与收汇；创业担保贷款；灵活就业的社保；骑手的职业伤害保障。口径：金钱/时间，拒服兵役那条兼及人身自由。
32. **出国留学：身份、打工、保险和回国认证**：交学费前查认证院校名单；美国 F-1「最长四年、读完 30 天内走」的新规被法院暂停，眼下仍是读完为止与 60 天宽限期；美加英澳四国的打工时数上限；全日制在读是身份的根；搬家 10 日内报备；教育部留学预警；澳大利亚 OSHC 不能断；英国医疗附加费；留服认证的 10 到 20 个工作日；被加强审查的院校名单。口径：金钱/人身自由。
33. **残疾之后怎么活**：自主神经反射异常的现场三步、致残后十年的自杀窗口、精神障碍住院的自愿原则与两种例外、照护者自己的死亡风险、轮椅减压坐垫、治愈系骗局、办证之后该问全的六项待遇、长期护理保险不只给老人、0—6 岁康复救助、家庭无障碍改造补贴、按比例就业与残保金、个税减征、导盲犬与免费乘车、高考合理便利、学校不得拒收与送教上门、C5 驾照、康复机构怎么挑、助听器、行为能力认定与监护。口径：死亡率/金钱/时间/人身自由。
34. **家里的常备药别吃出事**：对乙酰氨基酚别吃重复、孩子退烧不用阿司匹林尼美舒利安乃近、布洛芬伤胃的高危人群、2 岁以下不自己喂复方感冒药、怀孕 20 周后不自己吃布洛芬、奥美拉唑自己吃最多 7 天、感冒不要抗生素、腹泻先补液与孩子不给止泻药、止痛药吃多了反而头痛、过期药和剩药投有害垃圾、头孢甲硝唑期间和停药后 7 天不喝酒。口径：死亡率。

每节内条目按性价比从高到低排列。「不要早死」「不要浪费时间」这类节标题说的是这一节想防住的结果，条目本身要做还是别做，以条目标题为准。长文另见 [docs/家庭应急装备清单.md](#)、[docs/做平台要办哪些证.md](#)、[docs/结婚划不划算.md](#)、[docs/遇到陌生人出事该不该停.md](#)、[docs/生物钟和夜班.md](#)，以及四份按时间排的场景清单：[docs/被裁了之后先做什么.md](#)、[docs/孩子出生前后要办的事.md](#)、[docs/刚确诊慢性病之后.md](#) 和 [docs/换工作、换城市之前.md](#)。每条来源的核实过程记录在 [docs/核实记录](#)。

本书在 Claude Code 协助下编写：查找原始文献、逐条核对数字与原文是否一致、维护交叉引用和构建脚本。选题、取舍和最终审定由作者负责，每条数字都能在来源栏的原文里找到。

1. 不要早死

这一节讲三件事：车祸、火灾、中毒这类意外和伤害死亡；少数几种证据最硬的疫苗和筛查；身体出了什么信号就该去查一查。收益那一栏的数字，来自随机分组的试验、跟踪一大批人很多年的研究，或者官方统计。成本那一栏是作者按市面价格的粗略估计，只用来互相比较，不要拿去引用。

本节条目按主题分成下面几块，括号里是条号。

路上：系安全带（第 1 条），戴头盔（第 2 条），开车不超速、不酒驾（第 9 条），儿童安全座椅（第 10 条）。

家里的火、气、电：装烟雾报警器（第 3 条），燃气软管到期就换（第 4 条），电动自行车不推进楼道（第 6 条），备齐灭火器和急救包（第 26 条），装好护罩再用角磨机（第 42 条）。

孩子、老人和野外的意外：窗户装限位器（第 11 条），儿童近水不离视线（第 12 条），60 岁以上练平衡（第 13 条），不吃野生蘑菇（第 5 条），不捡来路不明的金属件（第 36 条），上野外冰面前量厚度（第 41 条）。

疫苗：查乙肝两对半（第 14 条），破伤风（第 15 条），HPV 疫苗（第 16 条），流感疫苗（第 20 条），带状疱疹疫苗（第 21 条），肺炎球菌疫苗（第 22 条）。

筛查和查病：量血压（第 7 条），查空腹血糖（第 8 条），乳腺癌筛查（第 17 条），宫颈癌筛查（第 18 条），结直肠癌筛查（第 19 条），查幽门螺杆菌（第 23 条），低剂量胸部 CT（第 24 条），骨密度检查（第 39 条），抗骨质疏松药（第 40 条）。

身体信号和性健康：尿里有肉眼看得见的血（第 27 条），勃起功能出问题先查心血管（第 28 条），减重戒烟能改善勃起功能（第 29 条），安全套和不共用针具（第 30 条），查艾滋病（第 31 条），暴露前预防药（第 38 条）。

心理危机：有自杀念头打 12356（第 25 条），自杀念头先告诉一个人（第 32 条），赌到借钱还赌（第 37 条），喝农药、吸煤气之后救回来的代价（第 33 条），高处坠落之后的代价（第 34 条），少一个肾的代价（第 35 条）。

1. 系安全带，前排后排都系

- 成本：不花钱。每次上车多花 2 秒。
- 说人话：坐前排系上安全带，出车祸时被撞死的概率大约降一半。坐轻型卡车前排的降六成。美国 2022 年死在车里的人，能查到系没系带的，有一半没系。
- 收益：美国交通安全主管部门（NHTSA）估计，系安全带能让轿车前排乘员受致命伤的风险下降 45%。轻型卡车前排下降 60%。2022 年美国死在乘用车（载人的小汽车）里的人当中，能查到系没系带的，有 50% 没系。世界卫生组织（WHO）的口径是，安全带让车内人员的死亡风险最多降低 50%。WHO 估计中国 2021 年死于道路交通事故的有 248,099 人，相当于每 10 万人里死 17.4 人
- 证据等级：A
- 来源：NHTSA (2024). Occupant Protection in Passenger Vehicles: 2022 Data (DOT HS 813 573). <https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813573> ; WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries> ; WHO GHO RS_196/RS_198 (China, 2021). [https://ghoapi.azureedge.net/api/RS_196?\\$filter=SpatialDim%20eq%20%27CHN%27](https://ghoapi.azureedge.net/api/RS_196?$filter=SpatialDim%20eq%20%27CHN%27)
- 备注：后排也要系。同一份报告里，第二排被撞死的人有 60% 没系带。45%、60% 这两个数，是美国交通安全主管部门（NHTSA）拿事故数据库算出来的估计（引 Kahane 2015），不是随机分组的试验。WHO 那个中国死亡人数是推算出来的，比公安交管登记的数字高好几倍。两边统计的范围不一样，这里只用 WHO 的口径。

2. 骑摩托车、电动自行车戴头盔并扣好

- 成本：买一顶 100 到 300 元。每次戴上花 5 秒。

- 说人话：戴头盔并且把扣带扣好，摩托车骑手出事时死亡的概率低约四成。头部受伤低约七成。扣带要系紧，松松垮垮挂在头上不算戴。
- 收益：Cochrane 把多项研究合起来一起算。摩托车骑行者戴头盔，死亡风险下降 42%。原值 OR 0.58，可信范围 95% CI 0.50 到 0.68。头部损伤下降 69% (OR 0.31, 95% CI 0.25 到 0.38)
- 证据等级：A
- 来源：Liu BC 等 (2008). Helmets for preventing injury in motorcycle riders. Cochrane Database of Systematic Reviews. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004333.pub3>
- 备注：头盔要把扣带扣好，挂在车把上不算戴。上面的数据来自摩托车。电动自行车没有直接研究，是照着推过来的，因为撞上以后头部受伤的方式相同。

3. 装烟雾报警器；冬天在室内烧煤、用燃气取暖的再装一氧化碳报警器

- 成本：烟雾报警器一个 30 到 100 元。一氧化碳报警器一个 50 到 150 元。装好以后每年换一次电池。
- 说人话：一个能正常工作的烟雾报警器，能把住宅火灾里死亡的概率降约六成。起火时有四成人在睡觉，光靠鼻子是醒不过来的。冬天在屋里烧煤或用燃气的，再加一个一氧化碳报警器。中国 2018 年有 1.15 万人死于一氧化碳中毒，冬天那三个月七成死在家里。
- 收益：美国北卡罗来纳州研究了一批住宅火灾，回头比对外出事和没出事的家庭。家里有一个能正常工作的烟雾报警器，死亡风险下降约六成。原值 OR 0.39，可信范围 95% CI 0.18 到 0.83。美国 2018 到 2020 年，有人住的住宅里发生的致死火灾，24% 家里没有烟雾报警器，41% 起火时人在睡觉。中国 2018 年报告一氧化碳中毒死亡 11,523 例。这些死亡里，12 月有 72.59%、1 月有 67.42%、2 月有 66.48% 发生在家中
- 证据等级：B
- 来源：Marshall SW 等 (1998). Fatal residential fires: who dies and who survives? JAMA. <https://doi.org/10.1001/jama.279.20.1633> ; USFA (2022). Fatal Fires in Residential Buildings (2018-2020), Topical Fire Report Series 22(2). <https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/statistics/v22i2.pdf> ; You J 等 (2020). Number of Deaths due to Carbon Monoxide Poisoning by Month and by Place of Death — China, 2018. China CDC Weekly. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2020.008>
- 备注：给 B 的原因：烟雾报警器这边只有一项研究，做法是回头比对外出事和没出事的家庭，不是随机分组的试验。一氧化碳报警器本身没有降低死亡率的研究。这里的收益是按「中毒死亡集中在冬季、集中在家中」推出来的。

4. 燃气软管和灶具到期就换，不自己改管道，燃气公司上门推销可以直接拒绝

- 成本：一根合规的燃气软管几十元。灶具几年换一次。换的时候顺手看一眼有没有过期。
- 说人话：一根合规软管几十块。到期就换，这是《城镇燃气管理条例》写明的用户义务。自己改管道、拆燃气表是条例明令禁止的。同一部条例还写了，燃气公司不能要求你买它指定的产品和服务。上门说「必须换」的推销，可以直接拒绝。
- 收益：条例把「及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管」写成了用户的义务：灶具和软管到了年限或者被国家淘汰了，你就要换。条例还把「擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置」列为禁止行为，自己动手改管道、拆燃气表都在里面。条例同时明确，燃气经营者不得要求用户购买它指定的产品，也不得要求用户接受它提供的服务
- 证据等级：C
- 来源：国务院 (2010). 城镇燃气管理条例（国务院令 第 583 号）第二十七条：「燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃气燃烧器具和气瓶，及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等」；第二十八条禁止行为含「（一）擅自操作公用燃气阀门」「（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线」「（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置」；第二十条燃气经营者不得「（六）要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务」；第二十九条用户可就收费、服务向燃气管理等部门投诉，「有关部门应当自收到投诉之日起 15 个工作日内予以处理」。 http://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1758214.htm；深圳市住房和建设局 (2024).

安全用气小知识（二）：「立即关闭家里的燃气总阀门」「迅速开门、开窗进行通风」「一定不要开、关家里的电灯、抽油烟机等电器」「人员应该迅速撤离，转移到安全的地方，并且及时拨打燃气公司的报警电话」. https://zjj.sz.gov.cn/zcjzts/content/post_11882410.html；张家港市应急管理局（2024）. 燃气安全使用知识：「不要情急之下打开排气扇进行通风」「应远离现场之后才能打电话求助」.

<https://www.zjg.gov.cn/zjgszwz/yjaqzs/202411/72b4fad7399c48378302460c6ce2d55b.shtml>

- 备注：条例原文能逐字核对，但它只说明到期换管是你的义务，不说明换了能少出多少事故。按年限换管能把燃气事故降多少，没找到官方统计数字，所以只给 C 级。有人以「安检」名义上门，检查完就推销自闭阀和报警器。条例第二十条第六项不许燃气公司要求你买它指定的产品，你可以拒绝，也可以投诉。闻到燃气味，先关燃气总阀，瓶装气关钢瓶阀门。再开门开窗通风，别开排气扇。电灯、抽油烟机这些电器一律别开也别关，打火机也别碰。然后人撤出去，离开现场再打燃气公司的报警电话。一氧化碳中毒是另一件事，见第 13 节。

5. 不采、不买、不吃野生蘑菇，任何「土办法鉴别」都不成立

- 成本：不花钱。难的地方是放弃一种季节性的野味。
- 说人话：光 2025 年一年，全国就有 828 起蘑菇中毒，2165 人中招，13 人死。那一年还新认出 34 种以前没记录过会毒人的蘑菇。银针试毒、虫子吃过就没毒、颜色鲜艳才有毒，这些说法全都不成立。
- 收益：中国疾控中心 2025 年调查了 828 起蘑菇中毒事件，涉及 2165 人，死亡 13 人。病死率 0.6%，指中毒的人里有 0.6% 死亡。2019 到 2024 年每年 276 到 676 起，病死率在 0.87% 到 2.86% 之间。光 2025 年就鉴定出 138 种有毒蘑菇，其中 34 种是国内第一次记录到会中毒
- 证据等级：A
- 来源：Mushroom Poisoning Outbreaks — China, 2025. China CDC Weekly (2026): 「In 2025, China CDC investigated 828 mushroom poisoning incidents across 27 provincial-level administrative divisions (PLADs), affecting 2,165 individuals and causing 13 deaths - a case fatality rate of 0.6%, the lowest of the past six years. In total, 138 poisonous mushroom species were identified, including 34 newly recorded in poisoning incidents in China.」 「From 2019 to 2024, the annual number of incidents ranged from 276 to 676, and the case fatality rate ranged from 0.87% to 2.86%.」 <https://doi.org/10.46234/ccdcw2026.120>；同刊 2024 年度报告 <https://doi.org/10.46234/ccdcw2025.106>
- 备注：吃错了就立刻催吐，然后带上剩下的蘑菇或者拍的照片去医院。毒蘑菇中毒分好几种类型，认出是哪一种蘑菇直接决定医生怎么治。每年都有新种类被记录到能毒人，所以「本地人认得清」这个前提本身站不住。银针验毒、和大蒜同煮、虫子吃过就没毒、颜色鲜艳才有毒，这些说法全都不成立。

6. 电动自行车不推进楼道、不进电梯、不在家里充电

- 成本：不花钱。难的地方是每次都停到楼下的集中充电点，多走几十米。
- 说人话：把电动车推进楼道、推进电梯，或者在家里充电，应急管理部的《高层民用建筑消防安全管理规定》明令禁止。不改正的，个人罚 500 到 1000 元，做生意的罚 2000 到 10000 元。罚款还是小事，要紧的是这种火正好烧在你唯一的逃生通道上。
- 收益：应急管理部的规章明文禁止：「禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电」。楼门厅、走道、楼梯间、安全出口这几处，既不能停车也不能充电。拒不改正的，不做生意的单位和个人罚 500 至 1000 元，做生意的罚 2000 至 10000 元
- 证据等级：A
- 来源：应急管理部（2021）. 高层民用建筑消防安全管理规定（应急管理部令第 5 号，第三十七条、第四十七条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/01/content_5628815.htm；应急管理部（2023）. 关于政协第十三届全国委员会第五次会议第 00969 号提案答复的函：「2021 年，全国共接报电动自行车火灾 1.8 万起，造成 65 人死亡、222 人受伤，直接财产损失达 2.21 亿元，其中发生在建筑

物内 3782 起，造成 60 人死亡、175 人受伤」. https://www.mem.gov.cn/gk/jytabljggk/zxwytaadfzy/2022zx/202301/t20230119_440918.shtml；应急管理部 (2025). 2025 年 1 月 15 日新闻发布会：「火灾起数同比下降 42.2%，伤亡人数下降超过 90%」. https://www.mem.gov.cn/xw/xwfbh/2025n01y15xwfbh_6337/

- 备注：别买改装电池，别用杂牌充电器，别整夜充着不管。锂电池一旦起火，几十秒里就整片烧开，同时冒出剧毒的烟。车停在楼道里起火，烧的就是你唯一的逃生通道。应急管理部公布的数字是，2021 年全国电动自行车火灾 1.8 万起，死 65 人。其中烧在建筑物里的 3782 起，死了 60 人，死者几乎都在室内。2024 年整治之后，火灾起数比上年降了 42.2%，伤亡降了九成以上，那一年的绝对数没有公布。

7. 量血压，高了就吃药降到达标

- 成本：电子血压计 100 到 200 元。量一次 1 分钟。降压药多数每月几元到几十元。难的地方是没症状也要接着吃。
- 说人话：血压每降 10 mmHg，出大的心血管毛病的概率降两成，中风降 27%，心衰降 28%，死亡概率降 13%。中国 35 到 75 岁的人里，44.7% 有高血压，真正控制住住的只有 7.2%。
- 收益：把 123 项试验、61 万余人合起来一起算。收缩压每降 10 mmHg，主要心血管事件低约两成。原值 RR 0.80，可信范围 95% CI 0.77 到 0.83。收缩压就是血压两个数里高的那个。卒中（中风）低约 27% (RR 0.73)。心力衰竭低约 28% (RR 0.72)。总死亡率下降 13% (RR 0.87, 95% CI 0.84 到 0.91)。中国给 35 到 75 岁的 170 万人做过筛查：44.7% 有高血压。这些人里，知道自己有的占 44.7%，在治疗的占 30.1%，控制住住的只有 7.2%
- 证据等级：A
- 来源：Ettehad D 等 (2016). Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01225-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8) ; Lu J 等 (2017). Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in China (China PEACE Million Persons Project). Lancet. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)32478-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32478-9)
- 备注：先去量一次血压。中国 10 个高血压的人里只有不到 1 个控制住了，所以量这一次是本书里性价比最高的动作之一。降到多少算达标（130 还是 140）还有讨论，但「知道自己高血压并把它降下来」这件事本身没有争议。

8. 35 岁以后只要超重，就去查一次空腹血糖，正常也每三年再查

- 成本：空腹血糖十几元。糖化血红蛋白几十元。去医院抽一次血就行。
- 说人话：花几十块抽一管血，就能在一点症状都没有的时候查出糖尿病前期。美国官方的筛查建议是：35 到 70 岁、超重或肥胖的人去查。查出来正常的，每三年再查一次。美国按体重指数 25 算超重，对亚裔放宽到 23；中国标准是 24 就算超重。
- 收益：美国预防服务工作组是美国官方给筛查建议的机构。它现在的建议是：对 35 到 70 岁、超重或肥胖的成年人筛查糖尿病前期和 2 型糖尿病，哪怕一点症状都没有。超重指体重指数 ≥ 25 ，肥胖指 ≥ 30 。对亚裔美国人，它建议把界线降到体重指数 ≥ 23 ，因为同样的体重指数下，亚裔的糖尿病风险更高。中国的行业标准是：体重指数 24.0 到 28.0 之间算超重， ≥ 28.0 算肥胖。这条建议的推荐等级是 B。它还写明：「对血糖正常的成年人，每 3 年筛查一次是合理的做法」
- 证据等级：A
- 来源：US Preventive Services Task Force (2021). Screening for Prediabetes and Type 2 Diabetes. <https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/screening-for-prediabetes-and-type-2-diabetes>：「at a lower BMI (≥ 23) if the patient is Asian American」；国家卫生健康委办公厅 (2024). 居民体重管理核心知识（2024 年版）释义：「根据《成年人体重判定》（WS/T 428-2013）行业标准..... $24.0 \leq \text{BMI} < 28.0$ 为超重， $\text{BMI} \geq 28.0$ 为肥胖」. <https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/P020240703481519509521.pdf>
- 备注：查出糖尿病前期不等于就要吃药。相当一部分人光靠改生活方式就能把它扭回去。中国成人里，知道自己有糖尿病的一直是少数，很多人是等到出了并发症才发现

9. 开车不超速、不酒驾

- 成本：不花钱。开慢一点，一趟多花几分钟。难的地方是饭局上少喝。
- 说人话：平均车速每高 1%，撞死人的概率高约 4%。酒精没有「喝一点没事」的安全线。血里的酒精浓度还很低的时候，风险就已经开始往上走了。
- 收益：世界卫生组织（WHO）的说法：平均车速每升高 1%，出人命的事风险升高 4%。酒驾的风险，从很低的血液酒精浓度起就开始上升
- 证据等级：B
- 来源：WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- 备注：速度和死亡的那组 1%、4%，是按事故模型推算出来的，不是随机分组的试验。酒驾这边 WHO 只给了方向，没给数字。「喝多少、风险涨多少」这个问题，本节没有核实过原始文献。

10. 给 4 岁以下儿童用安全座椅，不要抱在怀里

- 成本：一个 300 到 2000 元，能用几年。每次上车多花 1 分钟把孩子绑好。
- 说人话：一岁以下的婴儿坐安全座椅，车祸里受致命伤的概率低约七成。1 到 4 岁的孩子低约一半。抱在怀里没有这个效果，急刹车时你也抱不住。
- 收益：美国交通安全主管部门（NHTSA）估计，用安全座椅能让轿车里 1 岁以下婴儿受致命伤的风险下降 71%。1 到 4 岁的幼儿下降 54%。世界卫生组织（WHO）的口径是婴儿死亡下降 71%
- 证据等级：A
- 来源：NHTSA (2024). Occupant Protection in Passenger Vehicles: 2022 Data (DOT HS 813 573). <https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813573> ; WHO (2025). Road traffic injuries fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
- 备注：按说明书把座椅固定好，装错等于没装。1 岁以下要反向安装，让孩子面朝车尾。上面的数字是美国官方拿事故数据估出来的。

11. 家里有小孩就给窗户和阳台装限位器，纱窗不算防护

- 成本：一副窗户限位器或者儿童安全锁几十元。装上去十分钟。
- 说人话：一副限位器几十块钱。纽约市给高风险住户免费装窗户护栏、又上门讲解，一个区上报的儿童坠落数三年里降了一半。后来纽约干脆立法，要求房东给住着小孩的房子装护栏。纱窗一推就开，不算防护。
- 收益：纽约市从 1972 年起办了一个叫「孩子不会飞」的项目，在高风险城区免费发窗户护栏，还上门讲解。布朗克斯区上报的坠落数，1973 到 1975 年下降 50%。此后纽约市修改卫生法典，强制房东为住有 10 岁及以下儿童的公寓安装窗户护栏
- 证据等级：B
- 来源：Spiegel CN, Lindaman FC (1977). Children can't fly: a program to prevent childhood morbidity and mortality from window falls. American Journal of Public Health: 「Significant reduction in falls resulted, particularly in the Bronx, where reported falls declined 50 percent from 1973 to 1975」, 1976 年纽约市卫生法典修订 「to require that landlords provide window guards in apartments where children ten years old and younger reside」. <https://doi.org/10.2105/AJPH.67.12.1143>; (2021). Unintentional Window Falls in Children and Adolescents. Academic Pediatrics: 2007 年 1 月至 2017 年 8 月全国电子伤害监测系统 38,840 例急诊就诊, 「The majority of falls occurred in children under the age of 6 and were related to falls from a second story or below」. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2020.07.008>
- 备注：窗边和阳台边不要放床、沙发、箱子这类小孩能爬上去的东西。纱窗只挡蚊子，一推就掉，别把它当护栏。也不是只有住高层才要装：美国那份数据里，多数坠落发生在二层或者更低。

12. 儿童近水不离视线，划船、野泳穿救生衣

- 成本：救生衣 50 到 200 元。另外要搭上看着孩子的那份注意力。

- 说人话：落水的时候穿着救生衣，淹死的概率大约只有不穿的一半。溺水至今是中国 1 到 14 岁孩子的头号死因。农村的溺水死亡率大约是城市的两倍。
- 收益：用美国海岸警卫队的数据做的研究，把条件相近的人配成对来比。坐休闲船只落水的人，穿着救生衣的溺亡风险低约一半。原值是校正后 RR 0.51，可信范围 95% CI 0.35 到 0.74。中国 20 岁以下的溺水死亡率，从 2013 年的每 10 万人 6.60 人降到 2021 年的每 10 万人 3.28 人。农村约为城市的 2 倍。溺水仍然是 1 到 14 岁儿童的头号死因。2021 年 0 到 19 岁的伤害死亡里，溺水占 31.1%，道路交通占 27.9%
- 证据等级：A
- 来源：Cummings P 等 (2011). Association between wearing a personal floatation device and death by drowning among recreational boaters. *Injury Prevention*. <https://doi.org/10.1136/ip.2010.028688> ; Li Z 等 (2023). Unintentional Drowning Mortality Among Individuals Under Age 20 – China, 2013–2021. *China CDC Weekly*. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2023.198> ; Zhou J 等 (2024). Injury Mortality of Children and Adolescents Aged 0–19 Years – China, 2010–2021. *China CDC Weekly*. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2024.057>
- 备注：A 级只对应救生衣这一半。「不离视线」是大家的共识，单算只有 C 级，没有随机试验，以后也不会有。中国的溺水死亡集中在农村、夏季，以及 15 到 19 岁的男性。冬天上冰面玩，见第 41 条（野外冰面先量厚度）。

13. 60 岁以上练平衡和腿部力量，改造家里的浴室和楼梯

- 成本：每周练 2 到 3 次，每次 30 分钟太极或者平衡训练。浴室防滑垫、扶手、夜灯几十到几百元。难的地方是要长期练下去。
- 说人话：每周练两三次平衡，比如太极，老人跌倒的次数降约两成三，摔过的人数降 15%。家里做防滑、装扶手，再降约两成。跌倒是中国 65 岁以上老人因伤害死亡的头号原因，而且一多半就摔在自己家里。
- 收益：Cochrane 把 108 项试验、23,407 人合起来一起算。运动让老年人跌倒的次数下降 23%。原值是跌倒率之比 RaR 0.77，可信范围 95% CI 0.71 到 0.83。摔过的人数下降 15% (RR 0.85)。请人到家里做安全评估和改造，跌倒率下降约两成 (RR 0.81，95% CI 0.68 到 0.97)。练太极，跌倒风险低约 29% (RR 0.71)。在中国，跌倒是 65 岁以上老人因伤害死亡的头号原因。2018 年监测到的老年人跌倒，55.97% 发生在家中
- 证据等级：A
- 来源：Sherrington C 等 (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2> ; Gillespie LD 等 (2012). Interventions for preventing falls in older people living in the community. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007146.pub3> ; Lu Z 等 (2021). Characteristics of Falls Among Older People – China, 2018. *China CDC Weekly*. <https://doi.org/10.46234/ccdcw2021.013>
- 备注：这条适用于住在自己家里、不在养老院的 60 岁以上老人。上面的研究数的是跌倒次数，不是死亡人数。老人从跌倒到髋部骨折、再到死亡，这段路很短。看不清路也会多摔，白内障影响看路的见第 17 节第 9 条（白内障手术）。骨头经不起得起摔，见本节第 39 条（骨密度检查）。

14. 查乙肝两对半，没有抗体就打疫苗

- 成本：查一次几十元。成人乙肝疫苗 3 针合起来 100 到 300 元。半年之内打完。
- 说人话：查一次几十块。启东那项跟踪了 30 年的试验里，一出生就打了乙肝疫苗的人，后来得原发性肝癌的概率低 84%，身上带着乙肝病毒的比例低 72%。成人查出没抗体的补三针，半年打完，一两百块。
- 收益：启东那项试验按群体随机分组，不是按个人分组，跟踪了 30 年。新生儿接种乙肝疫苗，原发性肝癌下降 84%。可信范围是 95% CI 23% 到 97%。乙肝表面抗原 HBsAg 阳性率下降 72% (95% CI

68% 到 75%)，这个阳性率就是查出身上带着病毒的人所占的比例。中国全人群的 HBsAg 阳性比例，1992 到 2014 年下降 52%，5 岁以下下降 97%

- 证据等级：A
- 来源：Qu C 等 (2014). Efficacy of neonatal HBV vaccination on liver cancer and other liver diseases over 30-year follow-up of the Qidong hepatitis B intervention study. PLoS Medicine. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001774>; Cui F 等 (2017). Prevention of Chronic Hepatitis B after 3 Decades of Escalating Vaccination Policy, China. Emerging Infectious Diseases. <https://doi.org/10.3201/eid2305.161477>
- 备注：这条适用于 1992 年前出生、没打过疫苗或者抗体已经消失的成人。肝癌下降 84% 那个数来自一出生就打的人。同一项试验里，到青少年才补打的，防住病毒携带的效力只有 21%。成人打主要图的是不再被感染，不能直接套那个 84%。已经感染的人打疫苗没用，要去肝病科定期复查。怎么算已经感染：化验单上乙肝表面抗原 HBsAg 那一项是阳性。

15. 被铁钉、木刺扎到或者伤口沾了泥土，当天去处理，顺便问破伤风要不要打

- 成本：挂号加处理伤口几十元。医生说要打的话，疫苗或者免疫球蛋白几十到几百元。
- 说人话：破伤风一旦发病，大约每 10 个人里死 1 个。深的伤口、沾了泥土的伤口风险最高。伤口脏、离上一针满 5 年的，要加强 1 针。当天去处理花不了几十块，别拖到伤口肿起来再说。
- 收益：美国的破伤风病例里，大约每 10 例死 1 例。深的伤口、被泥土污染的伤口，风险更高。中国 2024 年的诊疗规范把伤口分成两档。6 小时内处理、没沾泥土粪便和动物口水的浅伤口，算低风险。超过 6 小时才处理、沾了这些东西，或者是扎伤、撕脱伤、挤压伤、烧烫伤、冻伤、伤口里留着异物的，算高风险。打过 3 针以上、最后一针不到 5 年的，什么都不用打。5 到 10 年的，高风险伤口加强 1 针。满 10 年的，不管哪档都加强 1 针。没打全 3 针或者记不清的，要把疫苗补全，高风险伤口还要同时打被动免疫制剂（免疫球蛋白或抗毒素这类直接给抗体的针）
- 证据等级：B
- 来源：美国疾病控制与预防中心. 破伤风：「Tetanus bacteria can get into someone's body through broken skin, usually through injuries.」「Tetanus can lead to death (1 in 10 cases in the United States are fatal).」「People who didn't complete the primary series or who aren't up to date with their 10-year tetanus booster shots are also at increased risk.」「Vaccination also helps prevent tetanus in people with wounds, depending on their tetanus vaccination history.」<https://www.cdc.gov/tetanus/about/index.html>; 国家卫生健康委办公厅 (2024). 关于印发非新生儿破伤风诊疗规范（2024 年版）的通知（国卫办医急函〔2024〕381 号，风险分级见附件第 16 页，表 4 见第 20 页）。https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6982262.htm; 附件 PDF（扫描件）。<https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/P020241023483425528555.pdf>
- 备注：到了医院让医生判断，别自己拿主意，也别嫌麻烦不问。不是所有伤口都要打。医生会看伤口属于哪一档，再问你上一次打针是什么时候，然后决定。「小时候打过就一辈子有效」是错的。伤口脏的话，离上一针满 5 年就要加强。所以去之前想一想自己最后一次打破伤风针是哪一年。

16. 女性接种 HPV 疫苗，越早越好

- 成本：国产二价约 300 多元一针，进口九价约 1300 元一针。一共打 2 到 3 针。每次跑一趟，半天。
- 说人话：瑞典 167 万女性的数据里，17 岁以前打过 HPV 疫苗的人，后来得浸润性宫颈癌的概率只有没打的约八分之一。17 到 30 岁才打的，也有一半左右。所以越早打越值。
- 收益：瑞典跟踪了 167 万名女性做统计：打过疫苗的人，浸润性宫颈癌的发病率比没打的低。17 岁以前接种的低约 88%（IRR 0.12，95% CI 0.00 到 0.34，括号里是原值和它的可信范围）。17 到 30 岁接种的低约 53%（IRR 0.47，95% CI 0.27 到 0.75）
- 证据等级：A
- 来源：Lei J 等 (2020). HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. New England Journal of Medicine. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1917338>